



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS

“ENRIQUE JOSÉ VARONA”

FACULTAD DE EDUCACION INFANTIL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACION LOGOPEDIA

**EJERCICIO DE CULMINACION DE ESTUDIOS
EXAMEN ESTATAL**

**ESTUDIO DE CASO A UN EDUCANDO DE LA INFANCIA
PREESCOLAR QUE PRESENTA UNA DISLLIA
FUNCIONAL**

AUTORA: Melissa de la Caridad Martínez Viera, 4to año, Plan de estudio E

TUTORA: Dr.C María Magdalena Fresquet Pedroso

La Habana

Curso escolar: 2021

Resumen

La siguiente investigación aborda temas relacionados con el estudio de caso de un educando que presenta una dislalia funcional asociada a una sobre protección familiar. El estudio de caso que a continuación se presenta, trata de explicar la vida del menor seleccionado, se desarrolla con el objetivo de proponer proponer un sistema de tratamientos logopédicos para corregir y/o compensar el trastorno de la comunicación que presenta el educando, teniendo en cuenta sus potencialidades y necesidades.

Palabras clave

estudio de caso, dislalia, tratamiento logopédico.

ABSTRACT

The following investigation approaches topics related with the case study of an educating that it presents a functional dyslalia associated to an on family protection. The case study that next is presented, he/she tries to explain the selected minor life, it is developed with the objective of intending to propose a system of treatments logopedico to correct y/o to compensate the dysfunction of the communication that presents the educating, keeping in mind their potentialities and necessities.

Key words

dyslalia, logopedico treatment, case study.

Índice

Introducción.....	1
Desarrollo.....	3
1.1Fundamentación teórica y metodológica del estudio de caso a un educando de la primera infancia que presenta una dislalia funcional.....	3
1.2 Resultados del estudio de caso. Propuesta de la estrategia de atención logopédica.....	12
I. Datos generales.....	12
II. Motivo de la selección para el estudio	12
III. Características del entorno familiar.....	12
IV. Características del entorno escolar.....	13
V. Dinámica del menor (o la menor) seleccionado.....	13
VI. Fundamentación de la Estrategia de Evaluación o sea de los instrumentos o pruebas seleccionados.....	14
VII. Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica.....	15
VIII. Conclusiones (Impresión Diagnóstica)	16
IX. Estrategia de intervención propuesta.....	16
Conclusiones.....	38
Recomendaciones.....	39
Anexos.....	41

Introducción

El estudio de caso constituye una fuente de información muy valiosa dentro del campo de la educación logopédica. Es un método científico y ordenado que tiene como objetivos principales buscar las causas que provocan la situación real manifestada en los educandos a los cuales se le realiza. Profundizar en las características individuales de cada uno de ellos en los diferentes contextos (familiar, escolar, etc.), y diseñar estrategias de intervención que contribuyan al pleno desarrollo de sus capacidades y a la corrección, compensación y prevención de las alteraciones del lenguaje y la comunicación. Este constituye el método cualitativo por excelencia en el proceso de diagnóstico, ya que desde que se realizan las primeras exploraciones en el niño y su entorno educativo más cercano: la escuela, la familia y la comunidad; de la evolución que se sigue durante el proceso de evaluación, caracterización y diagnóstico logopédico, depende que su pronóstico sea más favorable o no, por el hecho de considerar el papel decisivo de los mediadores para potenciar su desarrollo y favorecer una educación cada vez más inclusiva.

En el trabajo que se presenta, se ha realizado un estudio de caso teniendo en cuenta los parámetros que sugiere, Álvarez. C. (2006). De esta forma se han tenido en cuenta los fundamentos filosóficos del estudio de caso según el enfoque socio-histórico cultural, que corresponden a la ley genética del desarrollo, la situación social del desarrollo o ley dinámica del desarrollo, la zona de desarrollo próximo y unidad entre lo afectivo y lo cognitivo. Se aprecia el cumplimiento de cada uno de los principios del diagnóstico, como son su carácter individual y multilateral; carácter preventivo, retroalimentador y transformador; carácter multi e interdisciplinario, colaborativo y participativo; y su carácter dinámico, continuo y sistemático. Además, se tiene en cuenta para la elaboración del estudio de caso la atención logopédica del menor para el diagnóstico, corrección y compensación de los trastornos del habla que presenta el educando.

Los trastornos del habla se destacan por su relativa frecuencia en la edad preescolar, se presentan dificultades en la articulación de varios fonemas del idioma por causas orgánicas y/o funcionales. Por eso, a partir de los 4 años si persisten las dificultades es necesario realizar un tratamiento directo a la articulación. Desde la edad temprana se debe estimular el desarrollo del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas con los niños/as a partir de un modelo lingüístico adecuado para prevenir las alteraciones en la comunicación oral. En los años ochenta del siglo XIX, hubo intentos de clasificar los trastornos a partir de la existencia de las dislalias orgánicas y funcionales, consideraban que la incorrecta educación del lenguaje y la imitación eran causas de una dislalia funcional.

La dislalia constituye un trastorno en la pronunciación de los sonidos porque se produce una desviación de las normas adoptadas por la generalidad de un idioma dado, una vez surgida no se elimina de forma espontánea, para su corrección exige de procedimientos especiales, influye en el posterior desarrollo de los educandos. Se caracteriza por las alteraciones en el funcionamiento de los órganos periféricos del habla que dificultan la pronunciación por la sustitución, distorsión, omisión e inserción de fonemas en las distintas posiciones en la palabra (inicial, media y final).

El estudio de caso que se presenta a continuación es realizado a un menor del círculo infantil “Amiguitos de Nicaragua”, que cursa el 5to año de vida, y tiene como objetivo proponer un sistema de tratamientos logopédicos para corregir y/o compensar el trastorno de la comunicación que presenta el educando. Para ello se tuvo en cuenta las potencialidades del caso, para satisfacer las demandas educativas del educando en el área del lenguaje y la comunicación.

Desarrollo

1.1 Fundamentación teórica y metodológica del estudio de caso a un educando de la primera infancia que presenta una dislalia funcional

El estudio de caso, como el método más amplio y completo para hacer el diagnóstico psicopedagógico y logopédico de una persona y formular su orientación y atención. Es una investigación extensiva e intensiva que utiliza el aporte de todas las técnicas de evaluación y análisis posibles para llegar a una síntesis e interpretación de un caso. Este provee una armazón o estructura que sirve como guía para recoger, organizar y sintetizar toda la información obtenida sobre un sujeto; su naturaleza, causas de sus problemas, a fin de tratarlo y orientarlo.

El estudio de caso se realiza para determinar las mejores formas de satisfacer las necesidades educativas de un educando por lo que constituye una vía para el estudio de sus particularidades individuales, a partir del sistema de influencias educativas que ha recibido a lo largo de su vida. Constituye un proceso que abarca la investigación de su evolución, desde antes del nacimiento hasta la fecha en que se realiza la sesión de estudio; con la finalidad de analizar profundamente el grado de influencias positivas y negativas durante la trayectoria personal y familiar del educando. Son innumerables los autores que abordan temáticas sobre el estudio de caso, tanto en el ámbito internacional como nacional, y comienza a utilizarse con más frecuencia en las ciencias humanas y sociales como procedimiento de análisis de la realidad.

En el ámbito internacional se destacan autores como; Pressey y Robinson (1929) (Sayles, 1929); Shaffer (1936), Smith y Tayler (1942) y, algo más tarde, Skinner, (1951), se refieren a las ventajas del estudio de casos en las escuelas, con el fin de “lograr una adecuada apreciación del desenvolvimiento del niño hasta hacer posible un ritmo mayor de desarrollo para el futuro”.¹

¹Nieves, Ma, Luisa. El estudio de caso como método de diseño de la orientación educativa en la escuela.

Otros autores como Sabino, (1978), destaca que, “el estudio de casos más que un método de investigación, es una forma de diseño de la investigación”. Mientras que Orison (2003), reconoce, además, la importancia del estudio de casos como método de enseñanza, válido sobre todo en el área de las ciencias sociales”², y Walter, (1983) plantea: “es el estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado”.

En Cuba el estudio de casos es objeto de análisis y valoración por numerosos especialistas entre ellos Ortega (2001); Gutiérrez (2003); Torres (2004); Pérez Fowler (2005); Nieves (2007). Los investigadores realizan valiosos aportes en cuestiones referentes a sus usos como método de investigación científica, en el proceso de evaluación, diagnóstico y orientación; así como en la concepción de estrategias de intervención para el mejoramiento de la calidad educativa.

De acuerdo con la definición dada por la Dr.C. Marta Tórres (2004), se asume que: “el estudio de casos es un proceso de análisis, reflexión y debate que realiza el equipo interdisciplinario que participa en la evaluación y estudio de un sujeto, con el objetivo de explicar las características de su desarrollo evolutivo y los posibles factores causales que han determinado las mismas”.³Esta definición es abarcadora, destaca la influencia de agentes educativos, factores internos y externos que intervienen en el proceso de estudio y análisis para la profundización en el individuo objeto de estudio. Hace alusión al carácter sistémico de la investigación lo que contribuye a la solución de problemáticas.

El estudio de casos puede definirse como una descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o una entidad social. Los estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. Constituye un método cualitativo por excelencia en el proceso de diagnóstico.⁴

²Colectivo de autores. El estudio de caso como método científico de investigación en la escuela.

³Torres, M. Metodología para el estudio de caso, 2004. Pág.1

⁴ El método estudio de caso, pág. 2. Tomado de libro de Gloria Pérez, Investigación Cualitativa, Retos e Interrogantes.

La guía metodológica asumida es la propuesta por la Dr.C. Carmen Álvarez. (2006). Mediante esta se logró un adecuado conocimiento del desarrollo evolutivo del educando en los diferentes contextos, causas y estrategias para corregir y/o compensar las necesidades existentes. Siempre considerando los fundamentos pedagógicos, biológicos, sociales y psicológicos. A continuación, se determinan las principales dimensiones que declara esta guía metodológica.

I. Datos generales

II. Motivo de la selección para el estudio

III. Características del entorno familiar

IV. Características del entorno escolar

V. Dinámica del menor (o la menor) seleccionado

VI. Fundamentación de la Estrategia de Evaluación o sea de los instrumentos o pruebas seleccionados

VII. Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica

VIII. Conclusiones (Impresión Diagnóstica)

IX. Estrategia de intervención propuesta

El estudio de caso y la estrategia propuesta contribuye al pleno desarrollo del educando. Se auxilia, además, de métodos y técnicas de investigación como: observación, exploración logopédica, pruebas pedagógicas y psicológicas, análisis documental, entrevista, análisis y síntesis de la información recopilada. Todo en virtud de arribar al diagnóstico y la modelación de los tratamientos logopédicos que tendrán como objetivo: corregir y/o compensar el trastorno de la comunicación oral del nivel habla.

El lenguaje, como expresión del desarrollo psíquico e instrumento fundamental del pensamiento y la comunicación, se evidencia desde que el educando nace. Por su valor para el desarrollo cognitivo, comunicativo y la formación de la personalidad en general, exige que se enfatice en su estimulación y desarrollo desde la educación infantil; de ahí la importancia de la labor del docente

logopeda, en su tarea de prevenir, corregir y/o compensar los trastornos del lenguaje y la comunicación, además de brindar orientación a la familia y a las educadoras, para desde las edades más tempranas estimular el desarrollo del lenguaje de los educandos desde diferentes situaciones comunicativas.

Las insuficiencias en las estructuras anatómicas y funcionales encargadas de la ejecución del enunciado, constituyen esencialmente la base de los trastornos del nivel habla, siendo la dislalia el trastorno más frecuente en la población infantil. Donde se pueden observar con mayor incidencia dificultades en la pronunciación de los sonidos del idioma, independientemente del carácter orgánico y/o funcional que se manifiestan con un habla poco inteligible o ininteligible, cuando se trata de la alteración de varios sonidos del idioma, en los diferentes niveles de la articulación y que puede o no afectar al educando en su desarrollo en relación con el mundo que lo rodea.

Las investigaciones realizadas sobre dislalia están reflejadas en los trabajos de: Kussmaul (1879), cuando trata las alteraciones del componente sonoro del lenguaje; Berkan (1892); H. Gutzman, A. Liebmann (1924); Fröschels (1928) y posteriormente Shultzes, R. (1930), quienes coinciden en plantear que este trastorno está condicionado por defectos anatómicos en los órganos articulatorios. Para este trabajo se asume la definición de los autores Pascual, P. (1981); Figueredo, E. (1986); Rodríguez, X. (1993); Sos, A. y Sos, Ma. L., (1997) los cuales expresan: “La dislalia constituye una alteración en los fonemas del idioma que dificulta la pronunciación en diferentes situaciones comunicativas. Cuando el lenguaje oral se encuentra muy afectado por la implicación de varios fonemas, puede llegar a ser ininteligible”⁵

La dislalia se considera un trastorno del habla donde se altera el componente articulatorio por diferentes causas. De ahí la necesidad de profundizar en la clasificación por su funcionalidad para el diagnóstico y la intervención logopédica desde el momento de su detección, ellos son:

 Por su etiología (dislalia funcional, orgánica, audiógena)

⁵ Colectivo de autores. Logopedia Primera Parte. Textos para los estudiantes de las carreras Licenciatura en Logopedia y Educación Especial, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 2012. Pág. 108.

- ✚ Por la diversidad de sonidos alterados (simples o monomorfos, complejos o polimorfos)
- ✚ Por la forma en que se alteran los sonidos (omisión, distorsión, sustitución, inserción y/o adición)

Autores como A. Sos, M. L. Sos (1997) y Pascual. P (1981) tienen puntos de coincidencias al hablar de las causas de este trastorno, entre las que se encuentran: la escasa habilidad motora, se dificulta la motricidad fina, hay torpeza en los movimientos, falta de coordinación motriz en general y la discriminación auditiva. Por otra parte, inciden factores ambientales relacionados con la imitación de patrones lingüísticos incorrectos y el bilingüismo mal empleado durante las etapas de evolución y desarrollo del lenguaje.

Existen diferentes criterios, pero el que tiene mayor incidencia en la población infantil es la dislalia funcional que se caracteriza por alteraciones en el funcionamiento de los órganos periféricos del habla que dificultan la pronunciación y donde ocurre un debilitamiento de los procesos neurodinámicos superiores (excitación e inhibición).

Figueredo, E, señala que "... las dislalias funcionales se caracterizan por la presencia de una insuficiencia motriz o sensorial"⁶, de ahí que se clasifiquen estas en dos grupos: La primera, se caracteriza por la torpeza y poca diferenciación de los movimientos articulatorios; esto dificulta la emisión de sonidos complejos que exigen de movimientos exactos y diferenciados. En la segunda, con la presencia de una audición normal y/o conservada donde hay un insuficiente desarrollo del oído fonemático que dificulta la diferenciación de los fonemas semejantes acústicamente como /p/, /b/, /t/, /d/.

También estas pueden aparecer combinadas, por la insuficiente percepción fonemática y la formación del control cinestésico. Cuando se trata de una base motriz pura, el trastorno es fonético, al asociarse a un insuficiente desarrollo del oído fonemático, el trastorno es fonético-fonemático.

⁶Ibídem. Pág. 111

“El niño dislállico sabe que articula mal, quiere corregirse y trata de imitar al logopeda u otra persona que le corrige, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea, y no encuentran el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un sonido correctamente. Hay que considerar que la emisión del fonema es el resultado final de la acción de la respiración, la fonación y la articulación, es decir, del trabajo con el componente sonoro del lenguaje. Cuando existe una dificultad funcional en cualquiera de estos aspectos se altera la pronunciación de los fonemas del idioma. En otras ocasiones, aunque la dificultad sea la misma, el niño no percibe que articula bien o mal, por la fijación que se ha hecho de la dificultad y/o alteración en la articulación, se ha fijado un patrón negativo.”⁷

“Para la denominación de estos errores en la clasificación, se utiliza una terminología derivada del griego, con la terminación “tismo” o “cismo”. Así, por ejemplo, la alteración de la articulación de la /s/ se denomina sigmatismo, la de la /d/ deltacismo, entre otras. Cuando se sustituye un fonema por otro, se antepone “para”, como el pararrotacismo. También a los otros errores en la articulación de los fonemas se les denomina: betacismo(b); ceceo (c-z); checeo (ch); chionismo (sustitución de /r/ x /l/).”⁸

“En las dislalias es necesario distinguir las formas en que se altera la pronunciación de los sonidos del idioma y los errores en la pronunciación. Ambos casos son válidos para precisar las alteraciones en la pronunciación de los sonidos por omisión cuando un sonido se omite o desaparece por completo de una palabra, por sustitución cuando se reemplaza un sonido por otro, por distorsión cuando hay sonidos distorsionados, aproximados e indefinidos, que no derivan de una sustitución, su incorrección se debe a una mutilación, falta de claridad o descuido que da origen a un sonido débil o incompleto, así como la adición o añadidura y la transposición”⁹

⁷ Ibídem. Pág. 110

⁸ Ibídem. Pág. 110

⁹ Ibídem. Pág. 110

La dislalia funcional es un trastorno en la pronunciación que se puede corregir o compensar mediante la atención logopédica que reviste gran importancia no solo porque está dirigida a la prevención, corrección y/o compensación de los trastornos del lenguaje y la comunicación en sus diferentes niveles, tanto por las vías del tratamiento individual, en pareja o grupal, como por la labor del maestro desde la clase y el seguimiento que se realiza en la familia, a partir de las orientaciones que recibe como parte del sistema de influencias educativas, sino por lo que representa el lenguaje para el desarrollo cognitivo, el acceso al currículo y a la cultura universal.

1.2 Resultados del estudio de caso. Propuesta de la estrategia de atención logopédica

I. Datos Generales

-  Nombres y apellidos: JFHV
-  Fecha de nacimiento: 14 de abril del 2016
-  Edad: 4 años
-  Sexo: masculino
-  Grado o nivel educando: 5^{to} año de vida
-  Institución educativa: Circulo Infantil Amiguitos de Nicaragua
-  Dirección particular: Finca Cantarrana, número 25, Carretera Managua. Reparto Frank País, Arroyo Naranjo.

II. Motivo de la selección para el estudio

Se determinó realizar el estudio de caso al educando, por presentar dificultades en el lenguaje.

Las educadoras se acercan a la logopeda preocupada por el lenguaje oral de este menor, ya que las alteraciones que posee ocasionan dificultades en el proceso de comunicación y socialización del educando con sus coetáneos.

III. Características del entorno familiar

El educando convive en un hogar funcional y tranquilo con ambos padres y el abuelo materno. Sus necesidades básicas como alimentación, ropa, aseo etc. están cubiertas por sus mayores. Ambos se preocupan por la educación del educando, asisten a las reuniones de padres y colaboran con el centro en las

actividades que se realizan. Además, se muestran con correctos hábitos de educación formal lo que favorece a las relaciones familiares.

El entorno comunitario en que vive es un lugar tranquilo donde se observan instituciones recreativas para el disfrute del educando. La estructura y las condiciones de la vivienda son adecuadas, tiene tres cuartos, sala, baño, cocina-comedor, y portal. Además, poseen los electrodomésticos necesarios para la comodidad del educando. En los antecedentes patológicos familiares, el abuelo padece de hipertensión el educando es alérgico.

IV. Características del entorno escolar

Es un educando que presenta un ritmo de aprendizaje promedio. Reconoce los colores primarios y secundarios, así como las figuras geométricas y las vocales. Agrupa figuras por forma, tamaño y color, realiza conteo hasta 10 y es capaz de rellenar figuras sin salirse de los contornos. Identifica objetos de su entorno y es capaz de resolver por sí mismo conflictos que se le presentan en el juego y otras actividades. Ejecuta órdenes, comprende palabras y acciones sin dificultad.

Presenta dificultades en el área de la comunicación oral, lo que dificulta la participación en las actividades docentes ya que las educadoras muchas veces no comprenden lo que dice. Es un educando alegre, cariñoso y respetuoso con excelentes normas de cortesía y presenta buenos hábitos de conducta e higiene, asiste al centro correctamente aseado y peinado. Participa en las actividades de la escuela y en los matutinos.

V. Dinámica del menor seleccionado

Embarazo planificado, y deseado por ambos padres, transcurrió de forma normal con movimientos fetales fuertes. Parto a las 40 semanas sin complicaciones. El educando pesó 5,8 kg con llanto espontáneo. La lactancia materna se produjo hasta los 6 meses con buen reflejo de succión. Se sentó a los 4 meses, se paró a los 6 meses y dio sus primeros pasos a los 11 meses, caminó firme al año. En cuanto al lenguaje gorjeo y balbuceo a los 6 meses.

Padece de asma y es alérgico. Su desarrollo físicomotor es normal, desde su nacimiento, hasta el momento, sin anomalías ni retrasos en dicho desarrollo. Sus principales aficiones son jugar a los carritos y ver muñequitos de súper héroes.

A los cuatro años y medio por orientaciones de la enfermera del centro, la madre lo llevo a consultas de logopedia donde recibió orientaciones para estimular el lenguaje del escolar.

VI. Fundamentación de la Estrategia de Evaluación o sea de los instrumentos o pruebas seleccionados

Para la realización de este estudio se emplearon métodos de investigación teóricos y empíricos, procedimientos y técnicas tales como:

- ✚ Análisis documental del expediente, permitió conocer los datos anamnésticos, la evolución del lenguaje y el desarrollo psicomotor, la evolución de la menor desde su entrada al centro y la dinámica familiar.
- ✚ Observación, fueron observados los modos de actuación del menor en alguna de las actividades que normalmente realiza en el día durante dos semanas: llegada al centro, gimnasia matutina, actividades que se realizan en la mañana horarios de merienda, almuerzo y retorno al hogar.

Anexo 1.

- ✚ Encuesta a los especialistas; se entrevistó a la educadora que interactúa con el menor y a la enfermera del centro. Con ellas se pudo constatar mucha de las informaciones recogidas en los expedientes, así como sus criterios al respecto del caso en cuestión. **Anexo 2.**
- ✚ Entrevista a un miembro de la familia; se entrevistó a la madre con el objetivo de conocer datos referentes al proceso de embarazo y parto, evolución del lenguaje, enfermedades padecidas, estimulación que recibió el educando en los primeros años, entre otras cosas. **Anexo 3.**
- ✚ Técnica de exploración logopédica, se utilizó con el objetivo de observar el estado del lenguaje y tener argumentos para establecer un diagnóstico logopédico. **Anexo 4.**
- ✚ El test de clasificación se empleó con el objetivo de explorar los procesos de abstracción y generalización del pensamiento. Se emplearon 40 tarjetas que pertenecían a los siguientes grupos: animales, flores, personas, prendas de vestir, utensilio de cocina, utensilios de trabajo, muebles, juguetes, frutas y medios de transporte.
- ✚ Modelación: se realizó con el objetivo de modelar una estrategia de atención logopédica y el sistema de tratamientos logopédicos.

VII. Valoración integral de los resultados de la evaluación psicopedagógica

Resultado de la observación en las actividades docentes

Educando que asiste diariamente al centro y participa en las actividades que se realizan en el matutino. Se relaciona de forma positiva con sus compañeros, los cuales no le dan un trato diferente por su afectación en el lenguaje oral. Le gustan los juegos que impliquen actividad física y juegos de roles. Demuestra interés en aprender y en realizar todas las actividades que le orienta la educadora.

En el proceso de almuerzo mantiene buena conducta, respeta los turnos para recibir el almuerzo, su postura al sentarse a la mesa es buena, el uso de los cubiertos es correcta, sus modales son los adecuados (come con la boca cerrada, pide permiso para levantarse de la mesa). Durante su estancia en el círculo muestra respeto y cariño por todos los empleados del centro (da los buenos días y buenas tardes, sostiene conversaciones con estos, y los obedece).

Entrevista a especialistas (educadora y enfermera)

La educadora refiere que el educando se muestra siempre alegre y participa de forma activa en las actividades que se realizan, a pesar de muchas veces no comprender lo que dice. Asiste diariamente al centro y sus padres se preocupan por su aprendizaje.

Entrevista a la familia

El educando convive en un hogar funcional y tranquilo con ambos padres y el abuelo materno. Sus necesidades básicas como alimentación, ropa, aseo etc. están cubiertas por sus mayores. Ambos se preocupan por la educación del educando, asisten a las reuniones de padres y colaboran con el centro en las actividades que se realizan. Además, se muestran con correctos hábitos de educación formal lo que favorece a las relaciones familiares.

El entorno comunitario en que vive es un lugar tranquilo donde se observan instituciones recreativas para el disfrute del educando. La estructura y las condiciones de la vivienda son adecuadas, tiene tres cuartos, sala, baño, cocina-comedor, y portal. Además, poseen los electrodomésticos necesarios para la

comodidad del educando. En los antecedentes patológicos familiares no existe ningún indicio de enfermedades.

Test de clasificación

El educando reconoció cada uno de los objetos mencionados y fue capaz de nombrarlos. Formó de forma correcta los grupos, siendo capaz de generalizar los conceptos. Colaboro durante la realización de la actividad y se mostró animado.

VIII. Conclusiones (Impresión Diagnóstica)

Menor de 5 años de edad que presenta un trastorno de la comunicación oral, del nivel comunicativo habla, enmarcado en el componente articulatorio, es una dislalia funcional a predominio motriz, se afecta la motricidad articulatoria, asociado a una sobreprotección familiar y la imitación de patrones lingüísticos incorrectos que dificultan la estimulación y desarrollo del lenguaje, tiene un carácter primario. Presenta omisión de /s/, del fonema /k/ inconstantemente y del fonema /l / al final de la palabra, sustituye /k/ por /t/ inconstantemente y presenta dificultades en la pronunciación de palabras con directas dobles, (bl, br, fl, fr, pl y pr). Su vocabulario escaso en cuanto a volumen y calidad.

IX. Estrategia de intervención propuesta

La estrategia general de intervención logopédica, se personaliza en función de las particularidades del educando como resultado del proceso de diagnóstico, tiene como propósito satisfacer sus demandas educativas y potenciar su desarrollo de manera permanente. En ella se precisa el objetivo y las tareas que debe realizar el maestro logopeda, las que se concretan en el sistema de tratamientos logopédicos que desarrolla durante el curso escolar. A continuación, se precisa el objetivo y las tareas la estrategia general de atención logopédica.

Objetivo: Corregir y/o compensar el trastorno de pronunciación, la motricidad articulatoria y la discriminación auditiva, así como el enriquecimiento de su lenguaje para el desarrollo de la personalidad.

Tareas

- 1- Práctica fonética con ejercicios de estimulación inicial (respiración, gimnasia prearticulatoria con variedad de ejercicios de movilidad lingual, de soplo, otros)
- 2- Trabajo con la pronunciación de los fonemas alterados (diferentes etapas: preparatoria, instauración, automatización y diferenciación).
 - Instaurar: /s/ y /k/
 - Automatizar: //, y las directas dobles (bl, br, fl, fr, pl y pr)
- 3- Trabajo con el oído fonemático (variedad de ejercicios con este propósito)
- 4- Estimulación y desarrollo del lenguaje en diferentes situaciones comunicativas.
- 5- Desarrollo del vocabulario en cuanto a volumen, cantidad y significado.
- 6- Orientación a la familia, al maestro del aula y al resto de los especialistas involucrados en su educación.

La atención logopédica se caracteriza por el trabajo preventivo, correctivo-compensatorio y estimulador del desarrollo del lenguaje y la comunicación en preescolares y escolares de diferentes educaciones. Mediante el estudio de caso permite el diagnóstico de los diferentes trastornos de la comunicación que puedan presentar los educandos y brinda los recursos y apoyos para el desarrollo multilateral del educando y la evolución y seguimiento de los resultados que satisfagan necesidades y desarrollen potencialidades.

Sistema de tratamientos logopédicos:

Tratamiento 1

Eje temático: Los animales del zoológico.

Objetivo: Identificar los animales mediante diferentes situaciones comunicativas e instaurar el fonema /s/.

Método: Conversación.

Procedimiento: Observación, demostración y explicación.

Medios de enseñanza: rompecabezas, hoja de trabajo, espejo, cuento.

Material verbal: animales, zoológico, elefante, león, cocodrilo, mono, jirafa.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Lectura de un cuento para realizar preguntas de comprensión.

- a) ¿Te gusto el cuento?
- b) ¿De qué trataba el cuento?
- c) ¿Qué animales se mencionan?
- d) ¿Qué le paso a los animales?

Después de haber establecido un ambiente de confianza la logopeda le preguntará al educando que si le gusta visitar el zoológico y si la respuesta es afirmativa la logopeda puede hacer varias preguntas como:

- ¿Con quién lo has visitado?
- ¿Qué animales has visto?
- ¿Qué animal del zoológico te gusta más?

Estas preguntas, además de otras, no solo se realizan con el objetivo de estimular el lenguaje del educando, sino también para comprobar sus vivencias.

Orientación del objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los animales del zoológico y a pronunciar el sonido / s/.

Desarrollo

Actividad 1: 4- Se le presenta un rompecabezas y se le pide que lo arme:

- a) ¿Qué imagen estamos armando?
- b) ¿Menciona los animales que se ven en el rompecabezas?
- c) ¿Dónde viven los animales que se ven en el rompecabezas?
- d) ¿Cuál te gusta más y por qué?
- e) ¿Qué son todos?

Actividad 2: Realizar ejercicios prearticulatorios.

Movimientos de labios y de lengua

- Movimientos linguales en las 4 direcciones
- Tirar besos
- Emitir una sonrisa
- Chasquear la lengua

Actividad 3: Pronunciar frente al espejo.

Sigmoterapia inicial: Se le dice al educando ahora vamos a unir los dientes y vamos a hacer una sonrisa de payaso y vamos a hacer como la serpiente:

Ssssssss

Sigmoterapia + vocal: realizar el mismo procedimiento anterior pero esta vez vamos a añadirle al final una vocal acentuada:

Ssssá, ssssé, ssssí, sssó, sssú

Sigmoterapia extensa: Con los dientes unidos y los labios en forma de sonrisa forzada, vamos a realizar silbidos largos, suaves y finos terminando en vocales y después comenzando con vocales y por último terminando en vocal acentuada: Sssáasssassá, ssséssssé, sssíssssí, sssóssssó, sssússssú

Serie funcional s simple: Con los dientes unidos y los labios en forma de sonrisa forzada emitir silbidos suaves, largos y finos acompañados de vocales:

Sssasssassá, sssessssé, sssissssí, sssosssó, sssusssú

Serie funcional s compleja: Realizar secuencia de sonidos en la cual se comienza por una vocal a la cual siguen silbidos suaves, largos y finos, se repite la vocal, el silbido y se termina con la vocal acentuada:

Assssssasssá, essssssesssé, issssssissí, ossssssosssó, usssssssusssú

Repetir los ejercicios de dos a tres veces.

Actividad 4: Hoja de trabajo. Realizar un dibujo de un zoológico y pegar los animales de papel.

Para motivar al educando se le plantea una situación problemática.

A Pedro le regalaron varios animales (elefante, jirafa, león, cocodrilo y mono), pero como son tan grande no tiene donde ponerlos.

- ¿Quieres ayudar a pedro?

- ¿Cómo podemos ayudar a Pedro?

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas de cierre para comprobar si se apropió del contenido trabajado.

- ¿De qué conversamos hoy?
- ¿Qué animales conociste hoy?
- ¿Qué sonidos trabajamos hoy?
- ¿Cómo trabajaste hoy?
- ¿Te gusto la actividad?

Tarea:

Realizar un dibujo de su animal preferido.

Comenta con tu familia sobre los animales del zoológico.

Pronunciar el sonido / s/ frente al espejo.

Tratamiento 2

Eje temático: Los animales

Objetivo: Reconocer los animales mediante diferentes situaciones comunicativas y pronunciar el sonido / s/ en palabras.

Método: Conversación

Procedimiento: Observación y explicación.

Medios de enseñanza: tarjetas didácticas, espejo, lámina.

Material verbal: animales, zorro, gato, cebra, gallina, pollito, rana, murciélago, ballena, león, serpiente, sol, sola, sombra, lazo, mesa, lápiz, libros, sombrilla, silla, taza.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Se le presenta una lámina y se establece un diálogo breve acerca de esta:

- a) ¿Qué animal es ese?
- b) ¿Cómo es el animal? (grande o pequeño)
- c) ¿De qué color es?
- d) ¿Dónde vive?
- e) ¿Cómo hacen los perros? (sonido onomatopéyico)
- f) ¿A ti gustan los perros?
- g) ¿Tienes perro en casa? ¿Cómo se llama?

Orientación hacia el objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los animales y a pronunciar el sonido /s/ en palabras.

Desarrollo

Actividad 1: Mostrar tarjetas didácticas para nombrar los animales que aparecen en ellas.

- a) ¿Qué animales observas?
- b) Ejercicio de orientación espacial con las tarjetas.
- c) ¿Clasificar en domésticos, marinos y salvajes?
- d) ¿En qué se diferencian?
- e) ¿Qué son todos?

Actividad 2: Realizar ejercicios prearticulatorios.

Movimientos de labios y de lengua

- Movimientos linguales en las 4 direcciones
- Tirar besos
- Emitir una sonrisa
- Chasquearla

Actividad 3: Pronunciar frente al espejo.

Sigmoterapia + vocal: realizar el mismo procedimiento anterior pero esta vez vamos a añadirle al final una vocal acentuada:

Ssssá, ssssé, ssssí, ssssó, sssú

Pronunciar las palabras

-Sol – sola – sombra – lazo – mesa – lápiz – libros, sombrilla, silla, taza.

Actividad 4: Le presento una secuencia de imágenes de forma desordenada para que las arme y me describa que sucede en cada imagen con un orden lógico

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

- ¿De qué conversamos hoy?
- ¿Qué animales conociste hoy?
- ¿Qué sonido trabajamos hoy?
- ¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Pronunciar frente al espejo palabras con el sonido /s/ en el inicio, medio y final de la palabra.

Conversar con tus padres sobre los animales.

Tratamiento 3

Eje temático: Las partes de la casa.

Objetivo: Identificar las partes de la casa en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Conversación.

Procedimiento: Explicación, observación, demostración.

Medios de enseñanza: láminas de la casa, rompecabezas, espejo

Material verbal: partes de la casa, cocina, sala, baño, cuarto y comedor.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Se le presenta un rompecabezas para que arme y se le realizan preguntas de comprensión.

- ¿Qué observas? - ¿Que parte de la casa es? - ¿Que objetos hay en el cuarto?

Orientación hacia el objetivo: Hoy vamos hablar sobre las partes de la casa.

Desarrollo

Actividad 1: Mostrar lámina de las partes de la casa para que el educando las nombre.

Actividad 2: Observa la imagen.

- ¿Qué parte de la casa es?
- Describe que ves en la imagen.
- ¿De qué forma parte? (De la casa)
- ¿Es grande o pequeño?

Actividad 3: Se le pide al educando que describa su casa y se le realizan preguntas como:

- ¿En qué parte de la casa ves la televisión?
- ¿En cuál duermes?
- ¿En cuál cocina mamá?
- ¿En cuál te cepillas los dientes?

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué partes de la casa trabajamos hoy?

¿Qué sonidos trabajamos hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Realizar un dibujo relacionado con la parte de la casa que más te guste estar.

Tratamiento 4

Eje temático: Los objetos de la casa.

Objetivo: Nombrar los objetos de la casa y pronunciar palabras con el sonido /s/.

Método: Conversación.

Procedimiento: Observación y explicación.

Medios de enseñanza: tarjetas didácticas, láminas, hoja de trabajo, secuencia de láminas, adivinanza.

Material verbal: peine, cuchara, sombrero, florero, refrigerador, silla, televisor, mesa, tenedor, cama, sombrilla, sofá y ventilador.

Forma de organización: individual.

Evaluación: autoevaluación.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Decir una adivinanza.

Cuatro patas tienen,

así como asiento;

de ella me levanto y en ella me siento.

(La silla.)

Orientación hacia el objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los objetos de la casa.

Desarrollo

Actividad 1: Se le presentan varias tarjetas con objetos del baño y la cocina para que los nombre, diga la acción que se realiza con ellos y las características de cada uno.

Actividad 2: Muestro una lámina para que ubique los objetos que nombro.

Sombrero, florero, sombrilla, refrigerador y silla.

Actividad 3: Ordena la siguiente secuencia de láminas y narra lo que sucede en un orden lógico.

Actividad 4: Hoja de trabajo. Coloca los siguientes objetos en la parte de la casa que corresponde.

Objetos: televisor, mesa, tenedor, cama, sofá y ventilador.

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué sonidos trabajamos hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Colorea los objetos. Decir cual pertenece al cuarto y cual, a la cocina; y para qué sirven. (peine y cuchara)

Tratamiento 5

Eje temático: Los miembros de la familia.

Objetivo: Reconocer los miembros de la familia en diferentes situaciones comunicativas e instaura el fonema /k/

Método: Conversación.

Procedimiento: Observación, demostración y explicación.

Medios de enseñanza: fotos, Hoja de trabajo, láminas.

Material verbal: miembros de la familia, mamá, papá, hijo, abuelo, hermano, tíos, primos, abuela.

Introducción

Preparación de las condiciones previas donde se establecerá una conversación con el educando para que se sienta seguro y relajado. Se le harán algunas preguntas como: ¿Cómo te sientes hoy?, ¿Cómo llegaste hoy al círculo?, ¿Quién

te trajo al círculo? entre otras con el fin que este se sienta bien con las actividades que posteriormente se realizarán.

Motivación inicial: Narras sobre una lámina con un plan de preguntas.

- ¿Qué observas?
- ¿Quiénes son todos?
- ¿Qué está haciendo la familia?
- ¿En parte de la casa se encuentran?
- ¿Cuántos niños hay?, ¿Qué hacen?
- ¿Qué hace la mamá?
- ¿Dónde está sentado el papá?, ¿Qué color tiene el sofá?

Orientación hacia el objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los miembros de la familia.

Desarrollo

Para la realización de la siguiente actividad se le pidió a la familia fotos donde estuvieran todos los miembros de la familia.

Actividad 1: Mostrar las fotos al educando y realizar preguntas:

- ¿Qué observas?
- ¿Quiénes son todos?
- ¿Cómo están; felices o tristes
- ¿Dónde está mamá, papá, abuelo?
- ¿De qué color es la blusa de tu tía?
- ¿De qué color es el vestido de la abuela?
- ¿En parte de la casa se encuentran?
- ¿Dónde sirve la comida mamá?

Actividad 2: Realizar ejercicios prearticulatorios frente al espejo.

- Ejercitar la base de la lengua, retrayéndola y elevándola.
- Ejercicios de soplo corto y fuerte.
- Imitar el sonido de un reloj (tic-tac).

- Golpeteos con la punta de la lengua (toc, toc, tac, tac).

Actividad 3: Funcionalismo /K/

Dientes y labios separados, la punta de la lengua toca los alveolos inferiores y la base se eleva hasta tocar el paladar blando, formando una oclusión completa y emitir sonido kkka, kkka, kkka, kkka.

Repetir hasta que el educando logre la posición correcta para emitir el sonido.

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

Nombra los miembros de tu familia

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Realizar un dibujo relacionado con los miembros de tu familia.

Tratamiento 6

Eje temático: Las partes del cuerpo.

Objetivo: Pronunciar palabras con el fonema /k/ y reconocer las partes del cuerpo.

Método: Conversación.

Procedimiento: observación, explicación.

Medios de enseñanza: tarjetas didácticas, hojas de trabajo, material audiovisual,

Material verbal: partes del cuerpo, cara, hombros, brazos, pies, rodilla, manos, dedos, espalda, ojos, orejas, nariz, boca.

Introducción

Preparación de las condiciones previas.

Saludo

Motivación inicial: Después del intercambio con el educando se le presentara una canción, (material audiovisual), llamada “Cabeza, hombros, rodillas, pies”, esta canción trata sobre las diferentes partes del cuerpo y la cara. Se le realizarán preguntas sobre la canción; ¿Qué partes del cuerpo mencionan?, ¿Dónde están tus ojos?, muéstrame tus rodillas, ¿Con que parte del cuerpo comemos? Luego de la motivación se orienta el objetivo al educando, hoy vamos a reconocer las partes del cuerpo.

Desarrollo

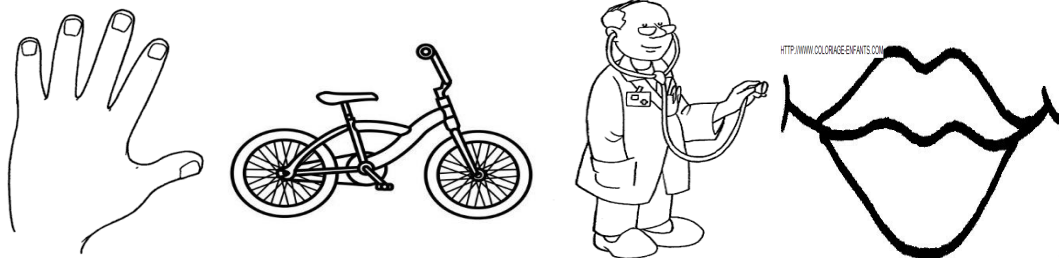
Actividad 1: Mostrar tarjetas sobre las partes del cuerpo y repetir las palabras que tengan el fonema /k/

Actividad 2: Frente al espejo señalar las partes del cuerpo.

Actividad 3: Pronunciar las siguientes palabras.

Cara, casa, cama, café, boca, queso, vaca

Actividad 4: Colorea las figuras que pertenecen a las partes del cuerpo.



Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Cuáles son las partes del cuerpo?

¿Qué sonidos trabajamos hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Pronunciar en casa palabras con el fonema /k/.

Reconocer las partes del cuerpo.

Tratamiento 7

Eje temático: Los medios de transporte.

Objetivo: Reconocer los medios de transporte en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Conversación.

Procedimiento: Observación, descripción, demostración.

Medios de enseñanza: tarjetas didácticas, rompecabezas, espejo, hoja de trabajo.

Material verbal: medios de transporte, aéreos, marítimos y terrestres, helicóptero, globo aerostático, avión, bicicleta, tren, barco, guagua, camión, moto, carro, tractor.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Se le presenta un rompecabezas para que arme y se le realizan preguntas de comprensión.

- ¿Qué es? - ¿Dónde está? - ¿Qué colores tiene? - ¿Para qué se utiliza?

Orientación hacia el objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los medios de transporte.

Desarrollo

Actividad 1: Tarjetas para nombrar los medios de transporte.

- Decir sus colores.
- Ejercicio de orientación espacial.
- ¿Para qué sirven?
- Clasificarlos en marítimos, terrestres y aéreos.

Actividad 2: Hoja de trabajo. Señala el medio de transporte más pequeño y colorea el más grande.

Actividad 3: Pronunciar frente al espejo. Hacer énfasis en la pronunciación de las palabras que tienen los fonemas /t/ y /k/.

Barco, camión, bicicleta, moto, guagua, tren, carro, tractor, helicóptero, avión.

Actividad 4: Hoja de trabajo. Nombra los medios de transporte que observas. Colorea el que se encuentra a tu izquierda.

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué medios de transporte trabajamos hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Hoja de trabajo. Circula los que son medios de transporte y nómbralos.

Tratamiento 8

Eje temático: Los oficios.

Objetivo: Nombrar los oficios en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Conversación.

Procedimiento: Observación, explicación.

Medios de enseñanza: rompecabezas, hoja de trabajo, secuencia de láminas, objetos reales, lámina.

Material verbal: albañil, bombero, policía, doctor, cocinero, barbero, maestro, carpintero, peluquera.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Observa la lámina.

- ¿Qué observas?
- ¿Qué hace el médico?

- ¿Dónde está el medico?
- ¿Qué le pasó al niño?
- ¿Cómo está el niño, triste o feliz?

Orientación del objetivo: Hoy vamos a conversar sobre los oficios.

Desarrollo

Actividad 1: Armar un rompecabezas.

- ¿Qué estas armando?
- ¿Qué observas?
- ¿Qué hace el hombre?
- ¿Qué herramientas utiliza? ¿Para qué?
- ¿Qué tiene puesto en la cabeza? ¿Por qué lo utiliza?

Actividad 2: Presentar las adivinanzas. Luego le muestro varios objetos para que identifique a quienes corresponden.

Con una manguera, casco y escalera

apago el fuego de la hoguera ¿Quién soy?

R/El bombero

Es el héroe de la comunidad y la
cuida noche y día para conservar
la seguridad.

R/ La policía

Actividad 3: Ordena la siguiente secuencia de láminas y narra lo sucedido en un orden lógico.

Actividad 4: Hoja de trabajo. Enlaza los oficios con la herramienta que corresponde en cada caso.

Actividad 5: Realizar preguntas y conversar sobre los distintos oficios.

¿En que trabajan tus padres?

¿Qué te gustaría ser cuando grande?

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué medios de transporte trabajamos hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Realizar un dibujo sobre lo que quisieras ser cuando grande.

Tratamiento 9

Eje temático: Las prendas de vestir.

Objetivo: Reconocer las prendas de vestir en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Conversación.

Procedimiento: Explicación, observación, demostración.

Medios de enseñanza: tarjetas, material audiovisual, hojas de trabajo, muñeco, espejo, objetos reales.

Material verbal: prendas de vestir, bufanda, blusa, corbata, camisa, abrigo, sombrero, chancletas, vestido, pantalón, zapatos, cinto, saya, medias, pulóver, delantal.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: Se presenta un video (material audiovisual), llamado "Juguemos en el bosque". En el video se muestran diferentes prendas de vestir que el educando deberá identificar. Después se realizarán preguntas de comprensión, relacionadas con el video.

- ¿Te gusto?
- ¿De qué trata?
- ¿Dónde vive el lobo?

- ¿Qué hacían los niños?
- ¿Qué objeto utilizó el lobo para peinarse?
- ¿Dónde se bañó el lobo?
- ¿Qué prendas de vestir utilizó el lobo?

Luego se le explica al educando que las prendas de vestir también se conocen como ropa, se confeccionan de diferentes materiales y se utilizan para vestirse y protegerse del clima.

Orientación del objetivo: Hoy vamos a conversar sobre las prendas de vestir.

Desarrollo

Actividad 1: Muestro tarjetas para nombrar las prendas de vestir. Preguntar en que parte del cuerpo se usa cada prenda y el color que tienen. Realizar ejercicios de orientación espacial.

Actividad 2: Le muestro al educando varias prendas de vestir y un muñeco para que lo vista con las prendas que le digo.

-Luego se le realizan las siguientes preguntas.

- ¿Quién lava la ropa en la casa?
- ¿Dónde lavan la ropa?
- ¿En qué parte de la casa está la lavadora?

Actividad 3: Hoja de trabajo, para nombrar las prendas de vestir y enlazar cada una con la parte del cuerpo donde se usa.

Actividad 4: Pronunciar frente al espejo las siguientes palabras haciendo énfasis en la correcta pronunciación de cada una.

Delantal, chancleta, blusa, camisa, sombrero, pantalón, pulóver.

Actividad 5: Hoja de trabajo. Colorea de color rojo la blusa que esta entre el pantalón y el vestido.

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué animales conociste hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Circula las prendas de vestir, nómbralas y colorea una.

Tratamiento 10

Eje temático: Las frutas y los vegetales.

Objetivo: Nombrar las frutas y los vegetales en diferentes situaciones comunicativas.

Método: Conversación.

Procedimiento: Descripción, observación

Medios de enseñanza: láminas, hoja de trabajo, tarjetas, cesta, objetos reales, adivinanza.

Material verbal: frutas, mango, guayaba, mamey, naranja, melón, plátano, fruta bomba, vegetales, tomate, pepino, cebolla, col, zanahoria, aguacate, pimienta.

Introducción

Saludo.

Motivación inicial: La logopeda le comunica al educando que la canasta que esta sobre la mesa tiene frutas y vegetales: “Ahora voy a sacarlos uno por uno para ver si los conoces o no”. A medida que se van mostrando el educando debe nombrar, clasificar en fruta o vegetal, decir color, forma y tamaño.

- Para que se utilizan los vegetales. (para cocinar y hacer ensaladas)
- Para que se utilizan las frutas. (para hacer jugos y dulces)

Orientación del objetivo: Hoy vamos a conversar sobre las frutas y los vegetales.

Desarrollo

Actividad 1: Se le muestra una lámina para que identifique los vegetales que se le nombre. ¿Qué son todos?

Actividad 2: Tarjetas con frutas y vegetales para nombrar.

- ¿Qué es?
- ¿Qué color tienen?
- ¿Qué forma tienen?
- ¿Qué son todas?
- Ejercicio de orientación espacial.

Actividad 3: Hoja de trabajo. Rellenar la figura (mango) con pedacitos de papel rasgados en forma de pellizco.

Actividad 4: Leer una adivinanza cuya respuesta es un vegetal.

- a) Decir nombre.
- b) Características. (color, forma, textura)

Un señor gordito,
Muy coloradito,
No toma café,
siempre toma te. (El tomate)

Conversar sobre la importancia de lavar las frutas y los vegetales antes de ingerirlos.

Conclusiones

-Se le realizarán preguntas:

¿De qué conversamos hoy?

¿Qué frutas y vegetales conociste hoy?

¿Cómo trabajaste hoy?

Tarea:

Nombra las frutas y los vegetales. Colorea las que sean frutas.

El sistema de tratamientos logopédicos propuesto en esta investigación fundamenta su trabajo teórico-metodológico en la concepción dialéctico-materialista del mundo. Esta concepción permite ver al ser humano desde una visión holística formado y desarrollado histórica y socialmente, por tanto, es una premisa fundamental para comprender las relaciones sociales. El vínculo de los

principios, leyes y categorías filosóficas permite establecer relaciones del fenómeno objeto de estudio. A partir del análisis objetivo-subjetivo de la problemática se puede arribar a un diagnóstico explicativo y diferencial con carácter sistémico, conocer el origen y las causas de la situación existente en el lenguaje que influye en el aprendizaje y en el desarrollo íntegro de la personalidad. La aproximación a los ejercicios y actividades logopédicas influyen en la transformación de los cambios cualitativos en cuantitativos y viceversa. El maestro logopeda actúa como mediador ante las actividades que propone con la familia y con otros docentes. Se revela la unidad entre la psiquis, la actividad y la comunicación, por ser en la actividad y por medio de la comunicación con los otros, donde se adquieren los aprendizajes en la vida. La interacción que se establece entre educando-familia-logopeda-educadora propicia la unidad de lo afectivo- cognitivo para el desarrollo de los procesos psíquicos superiores. En este sentido, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural revela la importancia del contexto donde tiene lugar el proceso de desarrollo del lenguaje; es por ello la orientación a la familia hacia la correcta articulación de los sonidos y la correcta comunicación para la vida en sociedad.

El enfoque histórico cultural de Vigotsky va orientado hacia el desarrollo psicológico de todo individuo; tiene su origen en la acumulación de vivencias, ve al hombre como un ser biopsicosocial. Los contenidos que se abordan ayudan al educando a ampliar sus vivencias. La profundización en el estudio de las causas biológicas es fundamental en la elaboración de la estrategia. Se tienen en cuenta las características para la asimilación de los contenidos. La comunicación depende en gran medida de la influencia de factores sociales. La familia debe ser un modelo lingüístico y comunicativo para el educando y los agentes sociales contribuyen en esa transformación positiva.

Desde el punto de vista educativo la dinámica seleccionada está en correspondencia con los fines de la educación y se destaca el carácter humanista de la educación cubana en la formación de un hombre integral. Las actividades responden a las necesidades del educando y tienen en cuenta sus potencialidades, además no se limitan a la escuela, se implica a la familia, la comunidad y la sociedad. Se utilizan videos, canciones infantiles, láminas y otros recursos que permiten la motivación. La metodología a utilizar en la organización

y diseño del sistema de tratamientos conlleva a la distribución del tiempo, los métodos y procedimientos, los medios de enseñanza, material verbal y sobre todo los ejes temáticos para ampliar el vocabulario activo y pasivo. El educando al ser valorado influye en su conducta y la misma se modifica para el próximo tratamiento. Se utilizan los procedimientos logopédicos y los psicoterapéuticos, tales como: las dramatizaciones, la rítmica logopédica, los diálogos, las narraciones, etcétera. Otras condiciones necesarias son la aplicación de técnicas logopédicas de instauración, automatización y consolidación de los fonemas mediante la rítmica logopédica. Se puede trabajar con la familia en el gabinete alguna de las actividades y el maestro también puede participar en este proceso. La frecuencia de cada tratamiento varía en dependencia de la cantidad de sonidos afectados, de la forma en que estos se afectan y de la evolución del escolar ante los ejercicios. La duración de cada tratamiento es de 15 a 20 minutos. Lo anteriormente fundamenta el carácter científico de esta investigación y la interdisciplinariedad de las actividades propuestas.

Conclusiones

Después de analizar los referentes teórico-metodológicos se pudieron constatar autores del contexto internacional y nacional que constituyen antecedentes de la investigación. Los conceptos que se asumen están en correspondencia con la concepción de la educación especial en Cuba y poseen actualidad. El estudio de caso que se propone refleja las condiciones de la vida familiar y escolar del educando.

La estrategia de atención logopédica planificada posee un carácter integral; está en coherencia con el diagnóstico, las necesidades del educando y en función de desarrollar sus potencialidades lo que permite una atención educativa más completa y eficaz.

Recomendaciones

- ✚ Aplicar los tratamientos elaborados a educandos con dislalia funcional.
- ✚ Continuar el trabajo con la familia para que se involucren más en la vida del educando y favorezcan el desarrollo de su comunicación y lenguaje.
- ✚ Elaborar variadas actividades que motiven al educando y permitan el desarrollo de la comunicación y el lenguaje del menor.
- ✚ Valorar la efectividad de los tratamientos modelados en la práctica pedagógica.

Bibliografía

COLECTIVO DE AUTORES. Logopedia Primera parte. Textos para los estudiantes de las carreras Licenciatura en Logopedia y Educación Especial, editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 2012.

DUBÉ Y. Estudio de caso. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2011

HERNANDEZ ARRONDO, D. La orientación Familiar en la corrección de las Dislalia mediante la tarea para la casa. Trabajo de diploma, Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", La Habana, Cuba, 2018.

NIEVES, MA, L. El estudio de caso como método de diseño de la orientación educativa en la escuela.

PEREZ, HIDALGO, L. Estudio de caso. Facultad de Educación Infantil, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", La Habana, Cuba, Año 2019- 2020.

PEREZ, G. Investigación cualitativa, retos e interrogantes, El método, estudio de caso, La Habana, Cuba.

TORRES, M. Metodología para el estudio de caso, La Habana, 2004.

ANEXOS

Anexo 1

Guía de observación

Tiene como objetivo observar los modos de actuación del educando durante su estancia en el círculo infantil.

Nombre y apellidos: _____

Edad: _____

Aspectos a observar

-Llegada al centro: _____

-Gimnasia matutina: _____

-Actividades que se realizan en el salón: _____

-Horario de almuerzo: _____

-Horario de merienda: _____

-Retorno al hogar: _____

Anexo 2

Encuesta a la educadora y enfermera.

Necesitamos su colaboración, para la investigación que realizamos, que tiene como objetivo indagar en diferentes aspectos del educando JFH que presenta un trastorno de la comunicación oral. Esperamos de usted, su más sincera colaboración.

Nombres y apellidos: _____

Años de experiencia: _____

1. ¿Conoce Ud. los tipos de trastornos del lenguaje y la comunicación que existen?

_____ Sí _____ No ¿Cuál? _____

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el educando?

3. ¿Cómo ha sido su evolución desde que trabaja con usted?

4. ¿Cree Ud. que el educando necesita atención logopédica?

_____ Sí _____ No _____ No sé

5. ¿Considera Ud. ser un modelo lingüístico para los educandos del centro?

_____ Sí _____ No _____ A veces

6. ¿Qué acciones ha desarrollado desde su especialidad que contribuyan al desarrollo del lenguaje y la comunicación del educando?

7. ¿Cómo son las relaciones del hogar con la escuela?

Anexo 3

Encuesta a la familia

Queridos padres:

Les proponemos contestar esta encuesta con la finalidad de lograr un diagnóstico más certero del educando. Le agradecemos de antemano su sinceridad en las respuestas.

1. El parto del niño fue:

A término _____ Prolongado _____ Prematuro _____ Cesárea _____

Con estimulación _____

2. ¿Cuándo gorjeó o balbuceó su hijo(a) por primera vez?

3 meses _____ 4 meses _____ 5 meses _____ 6 meses _____

3. ¿Cuándo pronunció sus primeras palabras?

5 meses _____ 6 meses _____ 7 meses _____ 8 meses _____ más tarde _____

4. ¿Cuándo su hijo logró imitar sonidos onomatopéyicos?

5 meses _____ 6 meses _____ 7 meses _____ 8 meses _____ más tarde _____

5. ¿Existió en algún momento presencia de vacilaciones o tropiezos en el habla de familiares?

No _____ Sí _____ Cuáles _____

6. ¿Existen antecedentes patológicos familiares con relación al lenguaje?

No _____ Sí _____ Cuáles _____

7. ¿Se siente usted orientada para poder atender el desarrollo lingüístico de su hijo?

Sí _____ No _____

8. ¿Ha recibido orientación profesional para estimular el desarrollo de su hijo?

Sí _____ No _____

9. ¿Reconoce usted la importancia de la labor del logopeda en función de la corrección del trastorno de su hijo?

10. El núcleo familiar está compuesto por: _____

Anexo 4

Hoja de exploración logopédica

Centro Circulo infantil "Amiguitos de Nicaragua"				
Nombres y apellidos JFHV				Expediente CDO
Fecha de nacimiento	Edad	Sexo	Grado	Cursos de repitencia
14 de abril del 2016	5 años	M	5 año de vida	
Procedencia del niño				
Motivo de consulta				
Presenta dificultades en el lenguaje.				
Datos concretos sobre la evolución del lenguaje				
Gorjeo y balbuceo a los 6 meses.				
Primeras palabras con 1 año.				
Otros datos de interés				
Llanto espontáneo al nacer. Se sentó a los 4 meses, se paró a los 6 meses y dio sus primeros pasos a los 11 meses, caminó firme al año.				
Examen específico del habla. Estado del aparato articulatorio				
No se aprecian alteraciones anatómicas, dificultades con la movilidad lingual.				
Características de la audición				
La audición impresiona normal ante los estímulos sonoros y la voz del logopeda.				
Estado de la expresión oral. Conversación espontánea. Características				
Se comunica mediante oraciones sencillas y se ayuda de los gestos para decir lo que quiere. Reconoce los colores primarios y secundarios, así como las figuras geométricas y las vocales; agrupa figuras por tamaño, colores y formas, y realiza conteo hasta 10.				
Vocabulario (volumen, calidad, significado)				
Presenta un vocabulario escaso en cuanto a volumen y calidad. Domina ejes temáticos como: juguetes, animales, frutas, vegetales y prendas de vestir.				

Estructura gramatical (análisis de las características morfológicas)

Presenta dificultades en la conjunción de verbos y omite algunos elementos gramaticales. Comprende ordenes sencillas, describe objetos de su alrededor.

Análisis de la pronunciación y de los procesos fonemáticos

fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F
a				k	OI	OI	OI	FL				ei			
e				g				GL				eu			
o				j				CL				oi			
i				t				BR				ou			
u				d				PR				ia			
m				n				FR				ie			
p				s	O	O	O	DR				iu			
b				l			OI	TR				io			
f				r				GR				ua			
ch				rr				CR				ue			
y				BL				ai				ui			
ñ				PL				au				uo			

Observaciones

Omite /s/ y el fonema /k/ inconstantemente en las tres posiciones.

Omite /l/ al final de la palabra.

Dificultades para pronunciar palabras con las directas dobles (bl, br, fl, fr, pl y pr)

Ritmo y fluidez del Lenguaje

El ritmo y la fluidez del lenguaje es el adecuado.

Características de la voz

No presenta alteraciones en las cualidades de la voz.

Intensidad: normal

Tono: agudo

Timbre: sonoro

Entonación: monótona

Examen de la lectura y escritura

Escritura

Conducta observada durante la prueba

Copero durante la prueba, se mostró tranquilo y realizo todas las actividades orientadas.

Diagnóstico logopédico

Menor de 5 años de edad que presenta un trastorno de la comunicación oral, del nivel comunicativo habla, enmarcado en el componente articulatorio, es una dislalia funcional a predominio motriz, se afecta la motricidad articulatoria, asociado a una sobreprotección familiar y la imitación de patrones lingüísticos incorrectos que dificultan la estimulación y desarrollo del lenguaje, tiene un carácter primario. Presenta omisión de /s/, del fonema /k/ inconstantemente y del fonema /l / al final de la palabra, sustituye /k/ por /t/ inconstantemente y presenta dificultades en la pronunciación de palabras con directas dobles, (bl, br, fl, fr, pl y pr). Su vocabulario escaso en cuanto a volumen y calidad.

Recomendaciones

- ✓ Instaurar los fonemas afectados.
- ✓ Automatizar el fonema /l/, el fonema /k/ y las directas dobles en palabras.
- ✓ Enriquecer el vocabulario activo y pasivo.
- ✓ No utilizar diminutivos.
- ✓ Orientar a la familia sobre la importancia de la estimulación del lenguaje y la corrección de la pronunciación cuando se producen desviaciones articulatorias.

Observaciones:

Fecha de inicio de la atención logopédica: 14 de diciembre de 2020